

医药生物周报（25 年第 21 周）

脓毒症治疗或迎来创新疗法，建议关注远大医药

优于大市

核心观点

本周医药板块表现强于整体市场，化学制药板块领涨。本周全部 A 股下跌 0.53%（总市值加权平均），沪深 300 下跌 0.18%，生物医药板块整体上涨 1.78%，表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨 3.58%，生物制品上涨 1.74%，医疗服务上涨 1.42%，医疗器械上涨 0.48%，医药商业上涨 1.15%，中药上涨 0.19%。医药生物市盈率（TTM）33.25x，处于近 5 年历史估值的 65.57%分位数。

脓毒症治疗或迎来创新疗法，建议关注远大医药。脓毒症是机体因急性感染引起的宿主反应失调所致的危及生命的器官功能障碍。脓毒症有较高的发病率和病死率。根据 WHO 官网，2020 年全球范围内新发脓毒症约 4890 万例，1100 万患者死亡，约占全球总死亡人数的 20%。脓毒症的治疗方法主要包括抗感染、液体复苏和器官损伤的功能支持，尚无针对性治疗手段。2018 年《脓毒症集束化治疗指南更新》提出采用“1 小时集束化治疗（hour-1 bundle, H1B）”策略，成为初步处理脓毒性休克的策略。近几十年鲜有针对脓毒症的创新药物上市，脓毒症反应的个体差异极大影响了治疗选择，不同的病因、器官功能状况、合并症和遗传因素等表现出不同的临床表型和机体反应，这也是脓毒症临床试验失败率高的主要因素。远大医药 STC3141 是全球首个以重新构建免疫稳态为核心的脓毒症治疗方案，中国 II 期临床研究成功达到临床终点，安全性、耐受性良好，且药代动力学特征也符合预期。STC3141 有望推动脓毒症治疗迈入新纪元，是潜在的重磅炸弹级别药物。建议关注远大医药。

5 月投资策略：关注创新药及创新产业链。创新药板块步入快速放量期，国内外商业化与对外授权齐发力，推动营收增长并加快盈利转折。CXO 板块中 CDMO 订单增长强劲，业绩持续验证，一体化龙头展现突围潜力。建议关注拥有差异化创新能力，产品具备全球商业化潜力的创新药公司，以及新签订单、在手订单高增长的头部 CDMO 公司。

风险提示：研发失败风险；商业化不及预期风险；地缘政治风险；政策超预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

公司 代码	公司 名称	投资 评级	总市值 (亿元)	归母净利润（亿元）					PE			
				2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E	
300760.SZ	迈瑞医疗	优于大市	2812	116.7	124.1	141.0	161.9	24.1	22.7	19.9	17.4	
603259.SH	药明康德	优于大市	1792	93.5	111.6	127.3	145.1	19.2	16.1	14.1	12.4	
300832.SZ	新产业	优于大市	455	18.3	20.4	24.3	28.8	24.9	22.3	18.7	15.8	
688617.SH	惠泰医疗	优于大市	394	6.7	8.8	11.3	14.7	58.6	45.0	34.8	26.8	
300633.SZ	开立医疗	优于大市	137	1.4	3.1	4.0	4.8	96.0	43.7	34.4	28.3	
688212.SH	澳华内镜	优于大市	65	0.2	0.5	1.0	1.2	311.0	121.0	66.7	52.7	
300685.SZ	艾德生物	优于大市	79	2.5	3.2	3.8	4.5	30.8	24.8	20.6	17.4	
688050.SH	爱博医疗	优于大市	145	3.9	5.2	6.4	-	37.3	28.0	22.8	-	
0512.HK	远大医药	优于大市	300	22.9	20.4	22.6	25.7	13.1	14.7	13.2	11.7	
9926.HK	康方生物	优于大市	686	(5.1)	0.3	7.3	17.9	(133.3)	2364.1	93.9	38.2	
6990.HK	科伦博泰生物-B	优于大市	665	(2.7)	(7.2)	(3.0)	4.8	(249.2)	(92.2)	(220.1)	139.9	
0013.HK	和黄医药	优于大市	171	2.7	25.0	8.6	11.8	62.9	6.8	19.9	14.5	
2162.HK	康诺亚-B	优于大市	104	(5.2)	(8.0)	(5.8)	0.5	(20.1)	(12.9)	(17.8)	215.7	
1530.HK	三生制药	优于大市	442	20.9	23.9	27.1	30.7	21.1	18.5	16.3	14.4	
1789.HK	爱康医疗	优于大市	58	2.7	3.3	4.0	4.8	21.3	17.5	14.4	12.1	

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究 · 行业周报

医药生物

优于大市 · 维持

证券分析师：陈曦炳

0755-81982939

chenxibing@guosen.com.cn

S0980521120001

证券分析师：彭思宇

0755-81982723

cnpengsiyu@guosen.com.cn

S0980521060003

证券分析师：张超

0755-81982940

zhangchao4@guosen.com.cn

S0980522080001

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《医药行业快评-ASCO 年会摘要发布，国产创新药成果丰硕》——2025-05-23
- 《海外制药企业 2025Q1 业绩回顾——美国药品价格改革叠加不确定的宏观环境》——2025-05-21
- 《推荐关注创新药及创新产业链——医药生物行业 2025 年 5 月投资策略》——2025-05-16
- 《A 股生物医药行业 2024 年报及 2025 一季报总结——关注创新药及创新产业链》——2025-05-16
- 《医药生物周报（25 年第 19 周）——美国药品价格改革回顾》——2025-05-13

内容目录

脓毒症治疗或迎来创新疗法，建议关注远大医药	4
新股上市跟踪	11
本周行情回顾	12
板块估值情况	14
投资策略	15
推荐标的	16
风险提示	18

图表目录

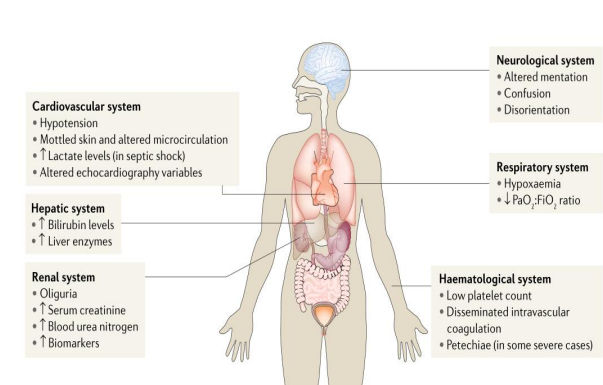
图 1: 在脓毒症患者临床监测中主要关注的器官系统	4
图 2: 2017 年经年龄标化的脓毒症发病率 (每 10 万人)	4
图 3: 脓毒症 SOFA 评分标准	4
图 4: 脓毒症当前的综合医疗策略	5
图 5: 2018 年《脓毒症集束化治疗指南更新》	5
图 6: 脓毒症的病理生物学	6
图 7: 2015 年以来具有里程碑意义的脓毒症临床实验	7
图 8: STC3141 的临床前动物实验体现良好的抑制组蛋白诱导的持续组织损伤的作用	8
图 9: 申万一级行业一周涨跌幅 (%)	12
图 10: 申万一级行业市盈率情况 (TTM)	14
图 11: 医药行业子板块一周涨跌幅 (%)	14
图 12: 医药行业子板块市盈率情况 (TTM)	14
表 1: 2000 年后部分进入临床 II 期或者 III 期的脓毒症治疗药物对于死亡率的影响情况	6
表 2: 近期 A 股/H 股医药板块新股上市情况跟踪	11
表 3: 本周 A 股涨跌幅前十的个股情况	13

脓毒症治疗或迎来创新疗法，建议关注远大医药

脓毒症是机体因急性感染引起的宿主反应失调所致的危及生命的器官功能障碍。脓毒症主要是由病原体（包括细菌、真菌、病毒及寄生虫等）相关分子直接激活免疫细胞和内皮细胞后大量释放影响包括中枢神经、呼吸系统、代谢系统等在内的机体各个系统的炎症介质。最常见的感染部位是肺部（占有病例的40%~60%）、腹部（15%~30%）、泌尿生殖系统（15%~30%）、血流、皮肤或软组织，但也存在地域差异。机体对免疫反应失调，引起危及生命的器官功能障碍，导致多器官衰竭和死亡，脓毒症是全球范围内导致死亡和长期残疾的主要原因之一。

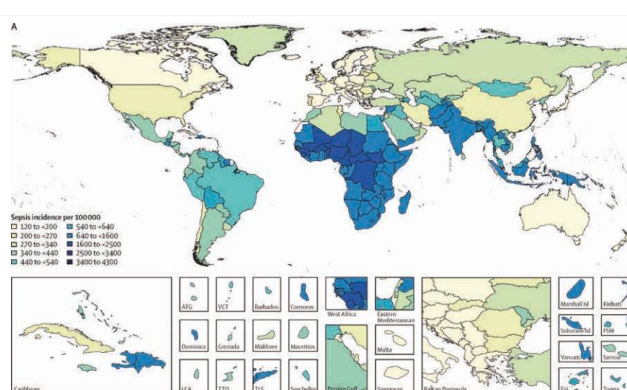
脓毒症有较高的发病率和病死率。根据 WHO 官网，2020 年全球范围内新发脓毒症约 4890 万例，1100 万患者死亡，约占全球总死亡人数的 20%。根据《中国脓毒症流行病学的研究进展》，依据 Sepsis 3.0 的定义重新计算中国基于人口标化后的成人脓毒症发病率为 236/10 万人口，相关死亡为 67/10 万人口，对应成人发病数和死亡数分别约为 330 万和 94 万。

图1：在脓毒症患者临床监测中主要关注的器官系统



资料来源：Nature Reviews，国信证券经济研究所整理

图2：2017 年经年龄标化的脓毒症发病率（每 10 万人）



资料来源：WHO，国信证券经济研究所整理

感染部位、病原体、一个或多个器官急性功能障碍以及基线健康状况的多种组合导致脓毒症临床表现的极大异质性。患者通常会出现感染的一般症状和体征（如发热或体温过低和乏力）、感染部位特有症状（如咳嗽、排尿困难或红斑）以及急性器官功能障碍症状（如意识错乱、少尿或呼吸困难）。然而及时识别脓毒症具有挑战性，因为脓毒症的表现多种多样，会随时间推移而变化，而且在病程早期可能并不明显。目前脓毒症诊断标准应同时满足以下 2 条：a) 确诊感染或疑似感染；b) SOFA 评分较基线增加 ≥ 2 分。

图3：脓毒症 SOFA 评分标准

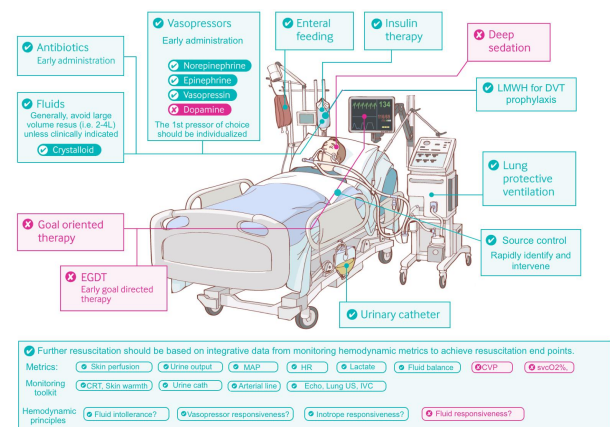
系统	评分/分				
	0	1	2	3	4
呼吸系统					
PaO ₂ /FiO ₂ /mmHg(kPa)	≥400 (53.3)	<400 (53.3)	<300 (40.0)	<200(26.7)+ 机械通气	<100(13.3)+ 机械通气
凝血系统					
血小板/(10 ³ · μl ⁻¹)	≥150	<150	<100	<50	<20
肝脏					
胆红素/[mg · dl ⁻¹ (μmol · L ⁻¹)]	<1.2 (20)	1.2~1.9 (20~32)	2.0~5.9 (33~101)	<6.0~11.9 (102~204)	≥12.0 (204)
心血管系统					
	MAP≥ 70 mmHg	MAP< 70 mmHg	多巴胺<5 或多巴酚丁胺 (任何剂量) ¹⁾	多巴胺 5.1~15.0 或 肾上腺素≤0.1 或去 甲肾上腺素>0.1 ¹⁾	多巴胺>15 或肾 上腺素>0.1 或去 甲肾上腺素>0.1 ¹⁾
中枢神经系统					
格拉斯哥昏迷量表评分 ²⁾ /分	15	13~14	10~12	6~9	<6
肾脏					
肌酐/[mg · dl ⁻¹ (μmol · L ⁻¹)]	<1.2 (110)	1.2~1.9 (110~170)	2.0~3.4 (171~299)	3.5~4.9 (300~440)	>4.9 (440)
尿量/(ml · d ⁻¹)	—	—	—	<500	<200

注：¹⁾ 儿茶酚胺类药物给药剂量单位为 μg/(kg · min)，给药至少 1 h；²⁾ 格拉斯哥昏迷量表评分范围为 3~15 分，分数越高代表神经功能越好。

资料来源：中国脓毒症/脓毒性休克急诊治疗指南（2018），国信证券经济研究所整理

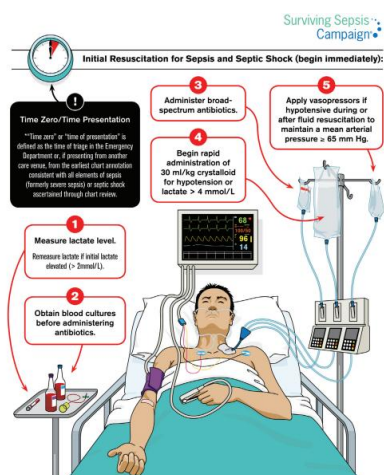
治疗脓毒症的重点是控制感染、恢复灌注和器官支持。目前，脓毒症的治疗方法主要包括抗感染、液体复苏和器官损伤的功能支持，尚无针对性治疗手段。2018 年《脓毒症集束化治疗指南更新》提出采用“1 小时集束化治疗（hour-1 bundle, H1B）”策略取代 3 h 和 6 h 的集束化治疗，成为初步处理脓毒性休克的策略。指南强调对于脓毒症患者的治疗是医疗紧急事件，1 小时内必须同时完成 5 个步骤：1）检测血清乳酸水平指导复苏；2）应用抗生素前留取血培养；3）广谱/联合/足量/全覆盖应用广谱抗生素，而后降阶梯治疗；4）液体复苏；5）血管活性药物应用：首选去甲肾上腺素。全球市场在脓毒症等重症治疗方面存在极大的临床未满足需求，在高收入国家，脓毒症患者的全院平均治疗费用超过 3.2 万美元。

图4：脓毒症当前的综合医疗策略



资料来源：RECAP EM，国信证券经济研究所整理

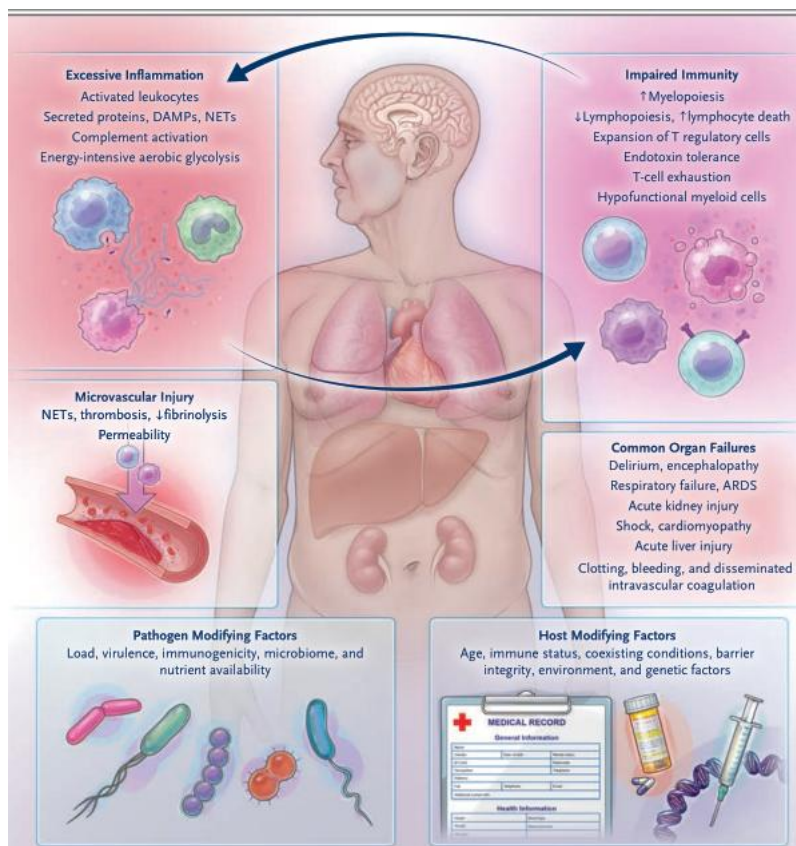
图5：2018 年《脓毒症集束化治疗指南更新》



资料来源：Surviving Sepsis Campaign，国信证券经济研究所整理

脓毒症的进展受病原体毒力和数量以及宿主特征（包括先天免疫激活、相对免疫抑制和适应不良的耐受机制）的影响。炎症反应的许多特征（细胞因子分泌、过度骨髓细胞生成和中性粒细胞-内皮细胞诱捕网[NET]生成）预计都会导致器官损伤，并使受到破坏的免疫稳态得以延续。

图6: 脓毒症的病理生物学



资料来源：NEJM，国信证券经济研究所整理

近几十年鲜有针对脓毒症的创新药物上市，礼来 Xigris 重组活化蛋白 C（屈曲可净α）是 FDA 在 2002 年批准上市的一款用于脓毒症的药物，却因上市后确证试验失败而于 2011 年撤市。从 20 世纪 90 年代到 21 世纪初，主要旨在抑制免疫反应的脓毒症免疫治疗试验在很大程度上失败了。脓毒症反应的个体差异极大影响了治疗选择，不同的病因、器官功能状况、合并症和遗传因素等表现出不同的临床表型和机体反应，这也是在脓毒症治疗中临床试验失败率高的主要因素。

表1: 2000 年后部分进入临床 II 期或者 III 期的脓毒症治疗药物对于死亡率的影响情况

类别	年份	患者（临床人数）	实验药物	对死亡率影响
Corticosteroids	2002	Septic shock and biochemical evidence of adrenal insufficiency (229)	Hydrocortisone and fludrocortisone	Benefit
	2008	Septic shock (499)	Hydrocortisone	No effect
Agents targeting LPS or TLR4	2000	Severe sepsis due to Gram-negative infection (1090)	E5 (a murine mAb that binds the lipid A domain of LPS)	No effect
	2000	Children with severe meningococcal sepsis (393)	rBPI21 (recombinant human bactericidal permeability-increasing protein)	No effect
	2010	Severe sepsis and septic shock respiratory failure (274)	orTAK-242 (a small-molecule inhibitor of TLR4-dependent signalling)	No effect

	2010	Severe sepsis (300)	Eritoran (a derivative of lipid A that acts as a TLR4 antagonist)	No effect
	2013	Severe sepsis (1,961)	Eritoran (a derivative of lipid A that acts as a TLR4 antagonist)	No effect
Agents targeting TNF	2004	Severe sepsis and high serum concentration of IL-6 (998)	Afelimomab (the F(ab') ₂ fragment of a murine TNF-specific mAb)	Benefit
Agents targeting PAF	2003	Severe sepsis without established ARDS (127)	Pafase (rhPAFAH)	Benefit
	2004	Severe sepsis (1,425)	Pafase (rhPAFAH)	No effect
Agents targeting the coagulation cascade	2003	Severe sepsis and elevated international normalized ratio (1,754)	Tifacogin (rhTFPI)	No effect
	2001	Severe sepsis (1,690)	Drotrecogin alfa (recombinant human activated protein C)	Benefit
	2007	Children with severe sepsis (477)	Drotrecogin alfa (recombinant human activated protein C)	No effect
	2012	Infection, SIRS and septic shock (1,697)	Drotrecogin alfa (recombinant human activated protein C)	No effect
Agents designed to upregulate immune function	2003	Severe sepsis and bacterial pneumonia (701)	Filgrastim (recombinant human granulocyte CSF)	No effect
	2013	Severe sepsis (194)	Talactoferrin (recombinant human lactoferrin)	Benefit
Miscellaneous agents	2009	Severe sepsis due to confirmed or suspected Gram-negative infection (1,379)	GR270773 (a phospholipid emulsion)	No effect
	2011	Septic shock (377)	Pyridoxalated haemoglobin polyoxyethylene	No effect

资料来源: Nature Reviews, 国信证券经济研究所整理

图7: 2015 年以来具有里程碑意义的脓毒症临床实验

Trial or Trials	Patients	Intervention and Control	Outcome	Interpretation and Lessons Learned
ARISE, ⁵⁷ ProCESS, ⁵⁸ and ProMISE ⁵⁹	ARISE: 1600 patients with septic shock at 51 sites in Australia and New Zealand ProCESS: 1341 patients with septic shock at 31 U.S. sites ProMISE: 1260 patients with septic shock at 56 U.K. sites	ARISE: EGDt vs. usual care ProCESS: EGDt vs. protocol-based "standard" therapy vs. usual care ProMISE: EGDt vs. usual care	ARISE: 90-day mortality, 18.6% vs. 18.8% (P=0.90) ProCESS: 60-day in-hospital mortality, 21.8% vs. 18.2% vs. 18.9% (P=0.83) ProMISE: 90-day mortality, 29.5% vs. 29.2% (P=0.90)	These trials showed that outcomes were similar with EGDt and usual care. Patients in these trials were less sick than those in the Rivers et al. trial (e.g., baseline ScvO ₂ 70% vs. 49%). ⁶⁰ However, there was no indication of benefit with EGDt across any subgroups examined in a meta-analysis of data from individual patients, including more severely ill patients. ⁶¹ Although these trials suggest that EGDt and usual care yield equivalent outcomes, EGDt is more labor-intensive, and standard care has evolved away from it.
ADRENAL and ⁶² APROCCHSS ⁶³	ADRENAL: 3800 patients with septic shock at 69 sites in Australia, United Kingdom, New Zealand, Saudi Arabia, and Denmark APROCCHSS: 1241 patients with multiorgan failure and septic shock at 34 sites in France	ADRENAL: hydrocortisone vs. placebo APROCCHSS: hydrocortisone plus fludrocortisone vs. placebo (and activated protein C vs. placebo)	ADRENAL: 90-day mortality, 27.9% vs. 28.8% (P=0.50) APROCCHSS: 90-day mortality, 43.0% vs. 49.1% (P=0.03)	Glucocorticoids were associated with reduced mortality in APROCCHSS but not in ADRENAL, although secondary outcomes in ADRENAL favored glucocorticoids. After these trials, guidelines were updated to include a weak recommendation to use glucocorticoids for persistent septic shock. ⁶³ However, the benefit varies among patients, so treatment decisions should be individualized.
SSSP-2 ⁶⁴	209 Patients with sepsis and hypotension at 1 site in Zambia	6-Hr sepsis bundle (administration of fluid boluses guided by JVP, vasopressors, and blood transfusion) vs. usual care	In-hospital mortality, 48.1% vs. 33.0% (P=0.03)	The sepsis bundle was associated with increased fluid delivery (median, 3.5 liters [≥70 ml/kg] vs. 2.0 liters [≥50 ml/kg] in the first 6 hr) and worse outcomes, underscoring the difficulty of translating sepsis management across settings and the need for further study of sepsis management in low- and middle-income countries.
PHANTAS ⁶⁵	2689 Patients with sepsis, identified in ambulance, at 34 sites in the Netherlands	Antibiotic administration before arrival at hospital vs. in hospital	28-Day mortality, 7.8% vs. 8.2%	In-ambulance antibiotic therapy yielded numerically but not significantly lower mortality. However, the difference of 0.4 percentage points is consistent with effect sizes in observational studies adjusted for less severely ill trial participants.

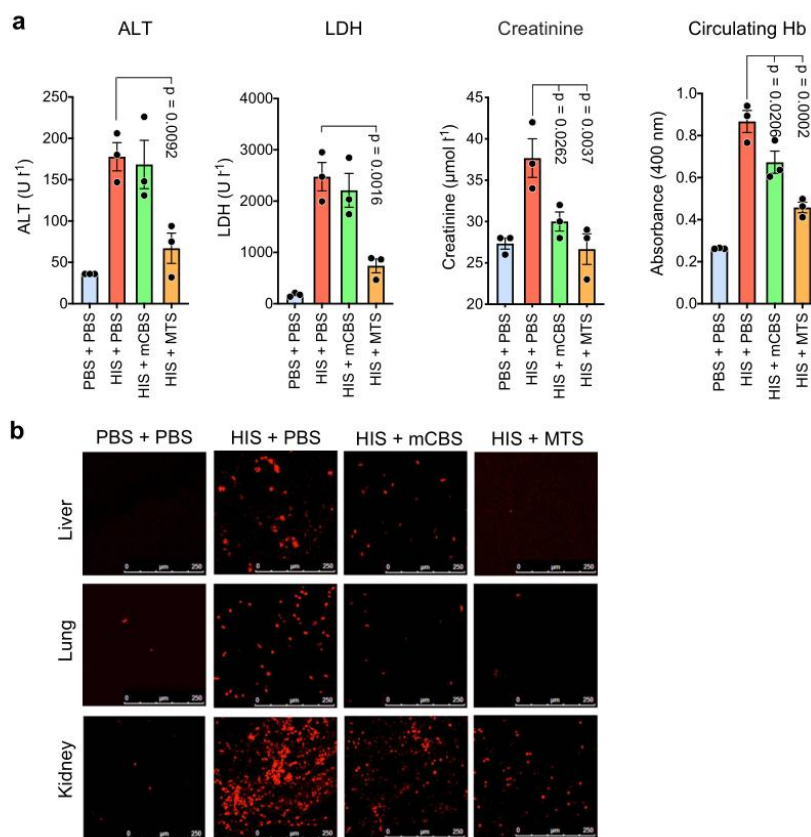
SMART ^{66,67} and BaSICS ^{68,69}	SMART: 15,802 patients (1641 with sepsis) at 1 U.S. site BaSICS: 10,520 patients (1987 with sepsis) at 75 sites in Brazil	SMART: balanced fluids vs. saline (0.9% sodium chloride) for IV fluid administration, with cluster randomization BaSICS: balanced fluids vs. saline (0.9% sodium chloride) for IV fluid administration	SMART: major adverse kidney event in overall trial population, 14.3% vs. 15.4% (P=0.04); 30-day in-hospital mortality among patients with sepsis, 26.3% vs. 31.2% (P=0.01) BaSICS: 90-day mortality, 26.4% vs. 27.2% (P=0.47); 92% probability of benefit among patients treated with balanced fluids before enrollment	These trials showed that resuscitation with balanced solutions is associated with better outcomes than resuscitation with normal saline, particularly among patients with sepsis and when used from the onset of resuscitation.
ANDROMEDA-SHOCK ^{70,71}	424 Patients with septic shock and lactate level ≥ 2.0 mmol/liter at 28 sites in Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, and Uruguay	Capillary refill normalization vs. lactate normalization	28-Day mortality, 34.9% vs. 43.4% (P=0.06)	Capillary refill-guided resuscitation was associated with better outcomes than lactate normalization. In practice, both methods can be used.
65 trial ⁷²	2600 patients ≥ 65 yr of age with vasodilatory shock at 65 U.K. sites	Low MAP target (60–65 mm Hg) vs. usual care	Unadjusted 90-day mortality, 41.0% vs. 43.8% (P=0.15)	A lower MAP target was associated with numerically lower mortality, a finding that suggests that a vasopressor-sparing approach is safe in older adults.
FRESH ⁷³	124 Patients with septic shock at 13 U.S. and U.K. sites	Personalized resuscitation strategy based on change in stroke volume after passive leg raise vs. usual care	Renal-replacement therapy, 5.1% vs. 17.5% (P=0.04); invasive mechanical ventilation, 17.7% vs. 34.1% (P=0.04)	This trial showed the feasibility and potential benefit of a personalized resuscitation strategy. Larger trials powered for important clinical outcomes are needed.
CLASSIC ⁷⁴ and CLOVERS ⁷⁵	CLASSIC: 1554 patients with septic shock at 31 sites in Europe CLOVERS: 1563 patients with sepsis-induced hypotension	CLASSIC: fluid-restrictive resuscitation vs. usual care CLOVERS: fluid-restrictive vs. fluid-liberal resuscitation	CLASSIC: 90-day mortality, 42.3% vs. 42.1% (P=0.46) CLOVERS: 90-day mortality, 14.0% vs. 14.9%; estimated difference, -0.9 percentage points; 95% CI, -4.4 to 2.6 (P=0.61)	Fluid-restrictive and fluid-liberal resuscitation yielded similar outcomes in the overall trial populations, which suggests that more personalized approaches may be needed. Nearly all patients received ≥ 30 ml of fluids per kilogram, so these trials provide no data on the safety of limiting resuscitation to <30 ml/kg.

¹ ADRENAL denotes Adjunctive Corticosteroid Treatment in Critically Ill Patients with Septic Shock, APROCCHSS Activated Protein C and Corticosteroids for Human Septic Shock, ARISE Australasian Resuscitation in Sepsis Evaluation, BaSICS Balanced Solution versus Saline in Intensive Care Study, CLASSIC Conservative versus Liberal Approach to Fluid Therapy of Septic Shock in Intensive Care, CLOVERS Crystalloid Liberal or Vasopressors Early Resuscitation in Sepsis, EGDIT early goal-directed therapy, FRESH Fluid Response Evaluation in Sepsis Hypotension and Shock, IV intravenous, JVP jugular venous pressure, PHANTASi Prehospital Antibiotics Against Sepsis Trial, ProCESS Protocolized Care for Early Septic Shock, ProMISe Protocolised Management in Sepsis, ScvO₂ central venous oxygen saturation, SMART Isotonic Solutions and Major Adverse Renal Events Trial, and SSSP-2 Simplified Severe Sepsis Protocol 2.

资料来源：NEJM、国信证券经济研究所整理

远大医药 STC3141 是全球首个以重新构建免疫稳态为核心的脓毒症治疗方案。STC3141 为远大医药自主开发、拥有全球知识产权、具有全新作用机制的小分子化合物，通过中和胞外游离组蛋白和中性粒细胞诱捕网来逆转机体过度免疫反应造成的器官损伤，可用于多种重症适应症。与既往脓毒症药物的开发思路都针对炎症反应中的淋巴细胞不同，STC3141 选择了与其相对的方向，针对的是炎症反应中的粒细胞。STC3141 实现了治疗维度的重大升级，在现有的抗感染、液体复苏和维持器官运转等对症支持治疗的基础上，针对机体免疫失调这个核心病因加以精准调节，帮助身体恢复平衡，填补了当前脓毒症针对病因治疗的临床空白。

图8：STC3141 的临床前动物实验体现良好的抑制组蛋白诱导的持续组织损伤的作用



资料来源：NATURE COMMUNICATIONS，国信证券经济研究所整理 注：ALT：丙氨酸氨基转移酶，肝功能指标；LDH：乳酸脱氢酶，普通组织；Creatinine：肌酐，肾功能指标；Circulating Hb：游离血红蛋白；PBS：磷酸盐缓冲液；mCBS：多阴离子分子的一种，实验名 STC3141；MTS：多阴离子分子的一种

STC3141 在中国开展脓毒症 II 期临床，研究进度处于全球脓毒症研究领域前列。该研究是一项评估静脉输注 STC3141 注射液在脓毒症患者中的疗效、安全性以及药代动力学特征的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的 II 期剂量探索临床研究（登记号 CTR20233109），入组 180 名接受标准治疗和护理的脓毒症患者，持续给药 5 天，并随访至第 28 天。研究的主要临床终点指标为第 7 天序贯器官衰竭评估（SOFA）评分（脓毒症诊断和评估疾病严重程度的标准）较基线的变化值；次要终点包括第 7 天 SOFA 评分较基线下降幅度达到 25% 的受试者比例、第 3 天和第 5 天 SOFA 评分较基线的变化值、28 天全因死亡率、无升压药物存活时间、无有创呼吸机存活时间、肾脏替代治疗/透析的使用率、住院时间、ICU 住院时间等有效性指标及 28 天内不良事件等安全性指标，旨在探索不同剂量药物在治疗脓毒症患者中的有效性和安全性。此项针对脓毒症的 II 期临床进展顺利，于 2023 年 7 月获药监局批准开展，2023 年 11 月首例临床入组，并于 2024 年 12 月完成全部受试者入组，比预定计划提前六个月，充分展示远大强大临床开发能力的同时，也说明重症治疗领域对于针对性治疗药物的迫切需求。

STC3141 在中国开展的用于治疗脓毒症的 II 期临床成功达到临床终点。结果显示，药物治疗组第 7 天 SOFA 评分较基线均有明显下降，尤其是高剂量组，降幅明显大于安慰剂组，差异具有统计学显著性和临床意义；次要终点的趋势与主要终点一致，符合预期。此外，STC3141 安全性、耐受性良好，且药代动力学特征也符合预期。结果证实了 STC3141 在脓毒症治疗中的有效性和安全性，为

重症治疗领域带来新的突破。

投资建议：全球年新发脓毒症约 4890 万例，超 1/5 的患者死亡，脓毒症的精准治疗是明确的未满足的临床需求。STC3141 是全球首个以重新构建免疫稳态为核心的脓毒症治疗方案，实现治疗维度的重大升级，填补临床空白。中国 II 期临床研究成功达到临床终点，安全性、耐受性良好，且药代动力学特征也符合预期。STC3141 有望推动脓毒症治疗迈入新纪元，是潜在的重磅炸弹级别药物。建议关注远大医药。

新股上市跟踪

◆ 近期 A 股/H 股医药板块新股上市情况跟踪

表2: 近期 A 股/H 股医药板块新股上市情况跟踪

证券代码	公司简称	上市进展	公司简介
1276.HK	恒瑞医药	5月23日上市	恒瑞医药创立于1970年，于2000年在上海证券交易所上市，是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业，聚焦肿瘤、代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病以及神经科学等领域进行新药研发，是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。公司持续加大创新力度，累计研发投入已超440亿元，位居全国医药行业前列。公司在中国、日本、美国、澳大利亚及瑞士设立了14个研发中心，全球研发团队超5500人。目前已在国内获批上市19款新分子实体药物（1类创新药）和4款其他创新药（2类新药），有90多个自主创新产品正在临床开发，约400项临床试验在国内外开展。公司还建立了PROTAC、肽类、单克隆抗体、双特异性抗体、多特异性抗体、ADC及放射性配体疗法等一批国际领先的技术平台，为创新研发提供强大基础保障。

资料来源：中国证监会，港交所，国信证券经济研究所整理

本周行情回顾

本周全部 A 股下跌 0.53%（总市值加权平均），沪深 300 下跌 0.18%，中小板指上涨 0.62%，创业板指下跌 0.88%，生物医药板块整体上涨 1.78%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨 3.58%，生物制品上涨 1.74%，医疗服务上涨 1.42%，医疗器械上涨 0.48%，医药商业上涨 1.15%，中药上涨 0.19%。

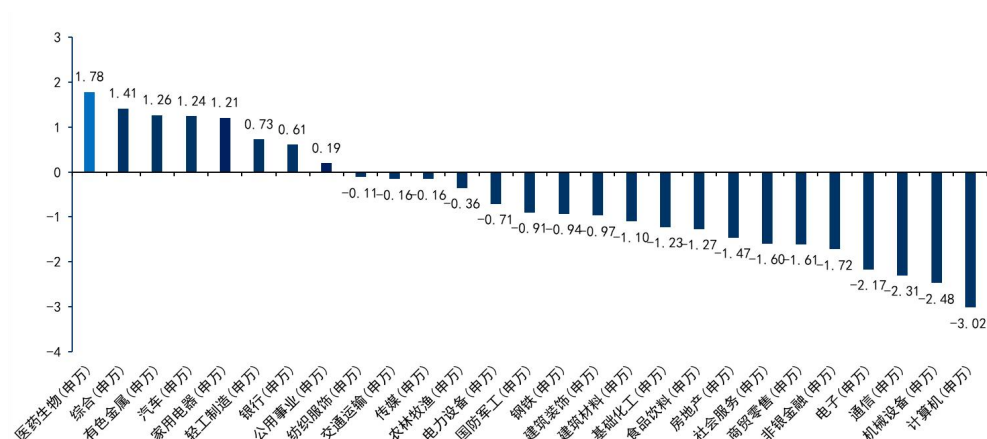
个股方面，涨幅居前的是三生国健（99.96%）、海辰药业（51.55%）、舒泰神（49.23%）、永安药业（45.32%）、一心堂（37.95%）、一品红（30.10%）、*ST 赛隆（27.66%）、睿智医药（24.72%）、海森药业（22.70%）、海翔药业（22.61%）。

跌幅居前的是明月镜片（-16.80%）、倍益康（-12.31%）、新赣江（-11.65%）、拱东医疗（-9.90%）、锦好医疗（-9.04%）、拓新药业（-8.68%）、欧康医药（-8.66%）、天目药业（-8.65%）、万泽股份（-8.37%）、金河生物（-8.07%）。

本周恒生指数上涨 1.10%，港股医疗保健板块上涨 5.57%，板块相对表现强于恒生指数。分子板块来看，制药板块上涨 13.58%，生物科技上涨 8.30%，医疗保健设备上上涨 0.66%，医疗服务上涨 1.94%。

市场表现居前的是（仅统计市值 50 亿港币以上）三生制药（57.38%）、欧康维视生物-B（34.51%）、百奥赛图-B（33.78%）、康宁杰瑞制药-B（32.84%）、四环医药（32.84%）；跌幅居前的是阿里健康（-14.29%）、巨子生物（-9.66%）、方舟健客（-8.79%）、同源康医药-B（-7.19%）、和铂医药-B（-4.24%）。

图9：申万一级行业一周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

表3: 本周 A 股涨跌幅前十的个股情况

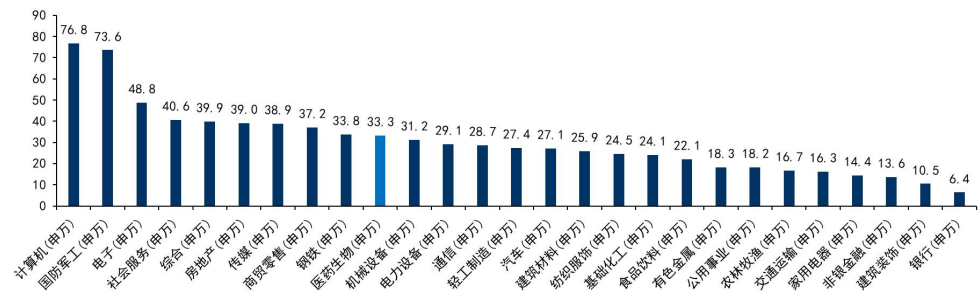
本周涨幅前十		本周跌幅前十	
股票简称	涨幅	股票简称	跌幅
三生国健	99.96%	明月镜片	-16.80%
海辰药业	51.55%	倍益康	-12.31%
舒泰神	49.23%	新赣江	-11.65%
永安药业	45.32%	拱东医疗	-9.90%
一心堂	37.95%	锦好医疗	-9.04%
一品红	30.10%	拓新药业	-8.68%
*ST 赛隆	27.66%	欧康医药	-8.66%
睿智医药	24.72%	天目药业	-8.65%
海森药业	22.70%	万泽股份	-8.37%
海翔药业	22.61%	金河生物	-8.07%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 注: 本表仅做列示, 不做推荐

板块估值情况

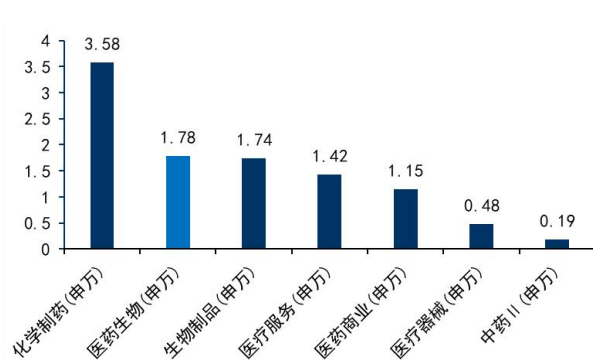
医药生物市盈率（TTM）33.25x，全部 A 股（申万 A 股指数）市盈率 18.43x。分板块来看，化学制药 39.71x，生物制品 39.51x，医疗服务 29.34x，医疗器械 33.77x，医药商业 20.26x，中药 27.52x。

图10: 申万一级行业市盈率情况（TTM）



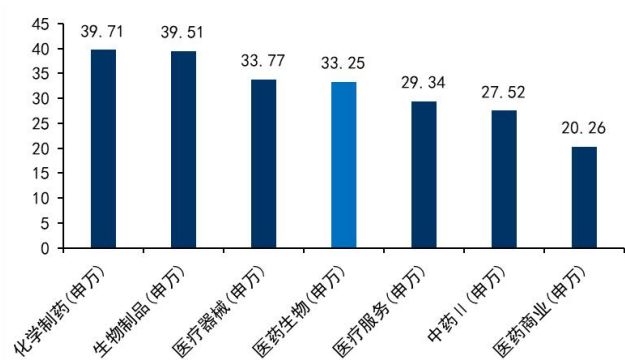
资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图11: 医药行业子板块一周涨跌幅（%）



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图12: 医药行业子板块市盈率情况（TTM）



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

投资策略

5月医药行业投资观点

医药板块整体业绩承压，板块间分化明显。医药行业 24 年报及 25 一季报发布，整体业绩承压。2024 年，分板块来看，各板块业绩出现较显著的分化，创新药板块营收同比大幅提升，疫苗、ICL 板块同比下滑较多；中药、CXO、生命科学上游、药店及 IVD 在利润端均承受较大压力。2025 年一季度，创新药板块（剔除大额授权收入后）仍有快速增长，疫苗、ICL、IVD 表现持续低迷，CXO 板块业绩出现回暖。

关注创新药及创新产业链。创新药板块步入快速放量期，国内外商业化与对外授权齐发力，推动营收增长并加快盈利转折。仿创结合企业创新药占比提升，仿制药受集采压制。中药板块短期承压但长期仍具品牌化与创新潜力。医疗器械受政策落地缓慢和库存影响短期承压，招投标回暖带动复苏预期；医疗服务受非刚需消费复苏滞后拖累，但 AI 赋能和细分赛道企稳为龙头企业带来新机遇。生命科学上游处于景气反转初期，海外需求回暖、国内企业加大研发与全球布局，有望重回高增速。CXO 板块中 CDMO 订单增长强劲，业绩持续验证，一体化龙头展现突围潜力。建议关注拥有差异化创新能力，产品具备全球商业化潜力的创新药公司，以及新签订单、在手订单高增长的头部 CDMO 公司。

投资策略：推荐关注创新药及创新产业链。2025 年 5 月投资组合：A 股：迈瑞医疗、药明康德、新产业、惠泰医疗、开立医疗、澳华内镜、艾德生物、爱博医疗、金城医学；H 股：康方生物、科伦博泰生物-B、和黄医药、康诺亚-B、三生制药、爱康医疗。

推荐标的

迈瑞医疗：公司作为国产医疗器械龙头，研发和销售实力强劲，国际化布局成果显著。公司受益于国内医疗新基建和产品迭代升级，并在海外加快高端客户拓展。微创外科、心血管等种子业务高速放量，“三瑞”数智化方案引领转型升级。

药明康德：公司是行业中极少数在新药研发全产业链均具备服务能力的开放式新药研发服务平台，有望全面受益于全球新药研发外包服务市场的快速发展。公司“一体化、端到端”的新药研发服务平台，无论是在服务的技术深度还是覆盖广度方面都能满足客户提出的多元化需求。

新产业：公司为化学发光免疫分析领域的龙头，拥有技术、生产和销售等方面的多重优势，坚实庞大的装机基础未来将持续带动试剂销售，促进进口替代，同时国际化和平台化布局将开启新成长曲线。

惠泰医疗：公司专注电生理和介入类医疗器械研发、生产及销售，在相关领域品种齐全、规模领先。已上市产品涵盖电生理、冠脉通路、外周血管介入及非血管介入医疗器械。2024 年迈瑞医疗完成对公司的控制权收购，成为实际控制人，凭借迈瑞在医疗器械领域的行业地位及丰富经验，公司有望实现海内外市场拓展及产品研发等方面的全方位赋能，巩固在心血管领域的领先地位。

开立医疗：开立医疗是国内“超声+软镜”行业领军企业，持续丰富业务矩阵，公司超声业务已经历 20 多年发展，建立了较为完善的营销网络渠道，超声行业也逐步进入成熟期。作为国产软镜后起之秀，开立在国内市场已跻身市占率第三。同时持续布局微创外科和心血管介入，新业务成长可期。

澳华内镜：公司为国产软镜设备龙头，软镜市场国产化率提升空间巨大，公司旗舰产品 AQ-300 于 2022 年底上市，性能媲美进口产品，目前市场推广进展顺利，有望带动收入高增长和盈利能力提升。

艾德生物：公司是肿瘤精准诊断领域的龙头企业，产品线布局领先，构建了从靶向治疗到免疫治疗的全方位伴随诊断产品体系，在院内渠道具备强大的销售壁垒；此外，公司产品顺利出海，中长期发展空间广阔。

爱博医疗：公司是国内首家自主开发高端屈光性人工晶状体的厂家，且在中国境内第 2 家取得角膜塑形镜注册证，隐形眼镜正处于快速放量阶段。公司拥有丰富在研管线，未来平台化和国际化发展潜力大。

金域医学：公司基于高强度的自主研发和产学研一体化，每年推出数百项创新项目，高端技术平台的不断完善和“医检 4.0”数字化转型战略落地将驱动公司盈利能力稳健提升。

康方生物(9926.HK)：公司为专注创新的双抗龙头，在研管线丰富，双抗、ADC、单抗等不同分子形态已形成梯队。依沃西持续验证 FIC & BIC 潜力，公司与 Summit 合作持续推进全球的临床。卡度尼利与依沃西已经成功实现了国内的商品化，有望成为重磅品种。

科伦博泰生物-B(6990.HK)：公司 ADC 产品早期临床数据优秀，研发进度在全球范围内较为领先，且已经与默沙东达成了深度的合作，有利于产品实现在全球的商业化潜力。公司未来 2~3 年的营收主要来源于默沙东的首付款和里程碑付款，产品销售将在 2025 年后开始放量。

和黄医药(0013.HK)：公司是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，专注

于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。呋喹替尼 2023 年底在美国获批上市后迅速放量，赛沃替尼也有望向 FDA 递交上市申请，索乐匹尼布临床数据优秀，预计将于 2025 年获批上市。

康诺亚-B(2162.HK)：公司的司普奇拜单抗是首个获批上市的国产 IL4R 单抗，季节性过敏性鼻炎适应症是司普奇拜单抗获批的第三个适应症，此前，成人中重度特应性皮炎适应症和慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症分别于 2024 年 9 月和 2024 年 12 月获批上市，三个适应症均有可能通过 2025 年的国谈进入医保。

三生制药(01530.HK)：公司是一家集研发、生产和销售为一体的生物制药领军企业，在肾科、皮肤科、自身免疫科、肿瘤科的药物有多年的研发、销售经验。

远大医药(00512.HK)：公司自 2015 年以来加速创新转型，已在抗肿瘤（核药、RDC 和基因疗法）、心脑血管精准介入和以及重症抗感染三个板块分别构建了“梯度化+差异化”的管线，期待钇[90Y]微球注射液持续销售放量，RDC 和脓毒症里程碑有望持续兑现。

爱康医疗(1789.HK)：公司是中国第一家将 3D 打印技术商业化的人工关节领域龙头公司，公司产品线齐全，借助集采提升市场份额，加速进口替代，巩固龙头地位。骨生物材料和数字化骨科将成为新增长点。

风险提示

研发失败风险；商业化不及预期风险；地缘政治风险；政策超预期风险。

附表：重点覆盖公司盈利预测及估值

代码	公司简称	子行业	总市值 (亿元)	归母净利润(亿元)				PE				ROE		PEG	投资 评级
				24A	25E	26E	27E	24A	25E	26E	27E	24A	25E		
300760.SZ	迈瑞医疗	医疗器械	2,812	116.7	124.1	141.0	161.9	24.1	22.7	19.9	17.4	32.5%	2.3	2.3	优于大市
300832.SZ	新产业	医疗器械	455	18.3	20.4	24.3	28.8	24.9	22.3	18.7	15.8	21.3%	1.5	1.5	优于大市
688212.SH	澳华内镜	医疗器械	65	0.2	0.5	1.0	1.2	311.0	121.0	66.7	52.7	1.5%	1.5	1.5	优于大市
688161.SH	威高骨科	医疗器械	103	2.2	2.9	3.4	-	46.1	35.3	30.1	-	5.7%	1.5	1.5	优于大市
688271.SH	联影医疗	医疗器械	1,137	12.6	17.0	20.8	23.3	90.1	66.8	54.8	48.9	6.3%	3.0	3.0	优于大市
688050.SH	爱博医疗	医疗器械	145	3.9	5.2	6.4	-	37.3	28.0	22.8	-	16.1%	1.0	1.0	优于大市
301363.SZ	美好医疗	医疗器械	98	3.6	4.6	5.7	6.9	27.0	21.1	17.3	14.1	10.5%	0.9	0.9	优于大市
688236.SH	春立医疗	医疗器械	55	1.2	3.0	3.6	-	44.3	18.5	15.5	-	4.4%	0.3	0.3	优于大市
300049.SZ	福瑞股份	医疗器械	80	1.1	2.1	2.8	3.6	70.3	38.5	28.5	22.1	6.5%	0.8	0.8	优于大市
300463.SZ	迈克生物	医疗器械	72	1.3	5.3	6.4	-	56.8	13.6	11.3	-	2.0%	0.1	0.1	优于大市
300685.SZ	艾德生物	医疗器械	79	2.5	3.2	3.8	4.5	30.8	24.8	20.6	17.4	13.8%	1.1	1.1	优于大市
688358.SH	祥生医疗	医疗器械	32	1.4	1.7	2.0	2.3	22.8	18.9	16.4	14.3	9.9%	1.1	1.1	优于大市
688389.SH	普门科技	医疗器械	55	3.5	5.1	6.2	-	16.0	10.9	8.9	-	16.8%	0.3	0.3	优于大市
688029.SH	南微医学	医疗器械	125	5.5	6.9	8.0	8.9	22.6	18.1	15.6	14.1	14.5%	1.1	1.1	优于大市
603301.SH	振德医疗	医疗器械	55	3.9	3.9	5.0	5.7	14.2	14.1	11.1	9.6	6.8%	1.0	1.0	优于大市
688626.SH	翔宇医疗	医疗器械	58	1.0	1.4	1.8	2.2	56.8	41.5	33.2	27.1	5.0%	1.5	1.5	优于大市
605369.SH	拱东医疗	医疗器械	41	1.7	1.6	1.9	2.1	24.1	25.6	21.8	19.3	10.1%	3.4	3.4	优于大市
300633.SZ	开立医疗	医疗器械	137	1.4	3.1	4.0	4.8	96.0	43.7	34.4	28.3	4.6%	0.9	0.9	优于大市
688575.SH	亚辉龙	医疗器械	84	3.0	5.1	6.7	-	27.8	16.3	12.6	-	10.9%	0.3	0.3	优于大市
688617.SH	惠泰医疗	医疗器械	394	6.7	8.8	11.3	14.7	58.6	45.0	34.8	26.8	26.8%	1.5	1.5	优于大市
002653.SZ	海思科	化学制药	493	4.0	5.5	6.9	8.7	124.7	90.2	71.2	56.9	9.4%	3.0	3.0	优于大市
688062.SH	迈威生物-U	生物药	95	(10.4)	(5.2)	(1.3)	-	(9.1)	(18.5)	(75.7)	-	-66.5%	0.3	0.3	优于大市
300601.SZ	康泰生物	生物药	155	2.0	8.1	10.0	-	77.1	19.3	15.6	-	2.1%	0.2	0.2	优于大市
688687.SH	凯因科技	生物药	46	1.4	2.0	2.6	-	32.0	22.8	17.4	-	7.7%	0.6	0.6	优于大市
688319.SH	欧林生物	生物药	62	0.2	0.7	1.3	-	298.0	95.2	46.5	-	2.2%	0.6	0.6	优于大市
688443.SH	智翔金泰-U	生物药	101	(8.0)	(6.7)	(4.4)	(0.5)	(12.7)	(15.1)	(23.0)	(215.3)	-37.5%	0.2	0.2	优于大市
688278.SH	特宝生物	生物药	303	8.3	10.7	15.4	21.7	36.7	28.3	19.7	14.0	32.4%	0.7	0.7	优于大市
000999.SZ	华润三九	中药	539	33.7	37.4	40.8	48.6	16.0	14.4	13.2	11.1	16.9%	1.1	1.1	优于大市
600557.SH	康缘药业	中药	73	3.9	6.1	6.8	-	18.7	12.0	10.9	-	8.7%	0.4	0.4	优于大市
600129.SH	太极集团	中药	119	0.3	13.0	15.6	-	447.3	9.2	7.6	-	0.8%	0.0	0.0	优于大市
688046.SH	药康生物	生命科学与工业上游	48	1.1	1.3	1.7	1.9	43.3	36.0	28.7	25.3	5.1%	1.8	1.8	优于大市
301080.SZ	百普赛斯	生命科学与工业上游	62	1.2	1.6	2.3	2.8	50.4	39.8	27.7	22.1	4.7%	1.3	1.3	优于大市
688293.SH	奥浦迈	生命科学与工业上游	47	0.2	0.8	1.1	1.5	221.2	59.7	41.6	30.4	1.0%	0.6	0.6	优于大市
603259.SH	药明康德	CXO	1,792	93.5	111.6	127.3	145.1	19.2	16.1	14.1	12.4	16.1%	1.0	1.0	优于大市
000739.SZ	普洛药业	CXO	162	10.3	11.2	12.6	14.0	15.7	14.4	12.9	11.6	15.3%	1.3	1.3	优于大市
603127.SH	昭衍新药	CXO	122	0.7	3.3	3.8	4.1	164.1	36.8	31.9	29.4	0.9%	0.5	0.5	优于大市
301096.SZ	百诚医药	CXO	41	(0.5)	0.5	0.9	1.2	(76.8)	76.5	47.1	34.9	-2.0%	-	-	优于大市
688076.SH	诺泰生物	CXO	121	4.0	5.8	7.9	11.0	29.9	20.8	15.2	11.0	15.2%	0.5	0.5	优于大市
688222.SH	成都先导	CXO	65	0.5	0.6	0.8	1.0	126.9	103.4	83.5	67.2	3.7%	4.4	4.4	优于大市
603882.SH	金域医学	医疗服务	135	(3.8)	6.9	8.5	-	(35.3)	19.6	15.9	-	-5.2%	-	-	优于大市
300015.SZ	爱尔眼科	医疗服务	1,173	35.6	41.4	48.8	57.6	33.0	28.4	24.1	20.4	17.2%	1.6	1.6	优于大市
1066.HK	威高股份	医疗器械	240	20.7	23.0	25.3	27.7	11.6	10.4	9.5	8.7	8.7%	1.5	1.5	优于大市
1789.HK	爱康医疗	医疗器械	58	2.7	3.3	4.0	4.8	21.3	17.5	14.4	12.1	10.4%	0.8	0.8	优于大市
2005.HK	石四药集团	化学制药	82	9.8	9.5	9.9	10.8	8.3	8.6	8.2	7.5	14.7%	2.6	2.6	优于大市
0512.HK	远大医药	化学制药	300	22.9	20.4	22.6	25.7	13.1	14.7	13.2	11.7	15.0%	3.7	3.7	优于大市
0013.HK	和黄医药	化学制药	171	2.7	25.0	8.6	11.8	62.9	6.8	19.9	14.5	5.0%	0.1	0.1	优于大市
2162.HK	康诺亚-B	生物药	104	(5.2)	(8.0)	(5.8)	0.5	(20.1)	(12.9)	(17.8)	215.7	-20.8%	0.1	0.1	优于大市
9926.HK	康方生物	生物药	686	(5.1)	0.3	7.3	17.9	(133.3)	2364.1	93.9	38.2	-7.6%	-9.4	-9.4	优于大市
1530.HK	三生制药	生物药	442	20.9	23.9	27.1	30.7	21.1	18.5	16.3	14.4	13.5%	1.4	1.4	优于大市
6990.HK	科伦博泰生物-B	生物药	665	(2.7)	(7.2)	(3.0)	4.8	(249.2)	(92.2)	(220.1)	139.9	-8.1%	0.4	0.4	优于大市
2480.HK	绿竹生物-B	生物药	38	(1.7)	(1.5)	(1.3)	1.2	(22.3)	(25.7)	(29.6)	32.4	-19.7%	0.1	0.1	优于大市
2268.HK	药明联合	CXO	408	10.7	14.0	19.2	26.0	38.1	29.2	21.3	15.7	16.1%	0.8	0.8	优于大市

2273.HK	固生堂	医疗服务	76	3.1	3.8	4.8	6.1	24.8	20.0	15.8	12.5	12.9%	0.8	优于大市
2666.HK	环球医疗	医疗服务	92	20.3	21.2	22.0	22.9	4.5	4.3	4.2	4.0	11.8%	1.0	优于大市

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理、预测

注：总市值以 2025/05/23 股价计算

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032